# Bilan biologique — normes françaises

Valeurs usuelles de l'adulte en unités SI, cible INR sous AVK fixée par le prescripteur, pièges d'unités et repères infirmiers, pour réviser en IFSI

Clairance

**Sommaire**


**Valeurs usuelles de l'adulte** ..... 1
**Fonction rénale : le DFG estimé** ..... 2
**Pièges d'unités** ..... 2
**Repères infirmiers** ..... 2


*Référentiel 2009 (entré.e.s en formation avant septembre 2026) : UE en lien, UE 2.1 « Biologie fondamentale » (S1) et UE 4.4 « Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical » (S2, S4, S5)*

**PIÈGE Les valeurs usuelles varient selon les laboratoires**

Interpréter un résultat avec les valeurs imprimées sur **le compte rendu du laboratoire**. Celles-ci viennent d'un référentiel national publié (adulte), pour réviser.

## Valeurs usuelles de l'adulte

| Examen | Milieu | Valeurs usuelles | Autre écriture |
|---|---|---|---|
| **Ionogramme et calcium** | | | |
| Sodium ($Na^+$) | Pl | 135–145 mmol/L | |
| Potassium ($K^+$) | Pl | 3,5–4,5 mmol/L | |
| Chlorure ($Cl^-$) | Pl | 95–105 mmol/L | |
| Bicarbonates ($HCO_3^-$) | Pl | 23–27 mmol/L | |
| Calcium total | Se ou Pl | 2,20–2,60 mmol/L | 88–104 mg/L |
| **Rein** | | | |
| Urée | Se ou Pl | 2,5–7,5 mmol/L | 0,15–0,45 g/L |
| Créatinine, homme | Se ou Pl | 60–115 µmol/L | 7–13 mg/L |
| Créatinine, femme | Se ou Pl | 45–105 µmol/L | 5–12 mg/L |
| Clairance de la créatinine (pour 1,73 $m^2$) | | 1,50–2,30 mL/s | 90–140 mL/min |
| **Glucose** | | | |
| Glucose | Pl | 3,90–5,50 mmol/L | 0,70–1,00 g/L |
| HbA1c (part de l'Hb totale) | Sg | < 0,06 | < 6 % |
| **NFS (hémogramme)** | | | |
| Hémoglobine, homme | Sg | 130–170 g/L | |
| Hémoglobine, femme | Sg | 120–160 g/L | |
| Hématocrite, homme | Sg | 0,42–0,54 | 42–54 % |
| **NFS (hémogramme)** | | | |
| Hématocrite, femme | Sg | 0,37–0,47 | 37–47 % |
| Hématies, homme | Sg | 4,5–5,7 T/L | |
| Hématies, femme | Sg | 4,2–5,2 T/L | |
| Leucocytes | Sg | 4,0–10,0 G/L | |
| Polynucléaires neutrophiles | Sg | 2–7,5 G/L | |
| Plaquettes | Sg | 150–450 G/L | |
| **Hémostase** | | | |
| Taux de prothrombine (TP) | Pl | 70–130 % | |
| TCA (rapport malade/témoin, sans unité) | Pl | 0,80–1,20 | |
| Fibrinogène | Pl | 2–4 g/L | |
| **Inflammation** | | | |
| CRP (protéine C réactive) | Se | < 5 mg/L | |
| **Bilan hépatique et protéines** | | | |
| ASAT | Se | < 35 UI/L | |
| ALAT, homme | Se | < 45 UI/L | |
| ALAT, femme | Se | < 34 UI/L | |
| GGT, homme | Se | < 55 UI/L | |
| GGT, femme | Se | < 38 UI/L | |

| Examen | Milieu | Valeurs usuelles | Autre écriture |
|---|---|---|---|
| **Bilan hépatique et protéines** | | | |
| Bilirubine totale | Se ou Pl | < 17 µmol/L | < 10 mg/L |
| Albumine | Se | 38–48 g/L | |
| Protéines totales | Se | 65–80 g/L | |
| **INR sous AVK : cible fixée par le prescripteur** | | | |
| INR sous AVK, cible la plus courante | | 2–3 | |
| INR sous AVK, certaines valves mécaniques | | 3–4,5 | |

*Milieu : Pl plasma, Se sérum, Sg sang. « Autre écriture » : seconde unité donnée par la source (équivalence arrondie). G/L = $10^9$/L ; T/L = $10^{12}$/L. Valeurs indicatives : elles varient selon le laboratoire.*

## Fonction rénale : le DFG estimé

Le **DFG estimé** (DFGe) se calcule à partir de la créatininémie (formule CKD-EPI chez l'adulte, recommandée par la HAS) et s'exprime en mL/min/1,73 m². DFGe < 60 pendant plus de 3 mois : maladie rénale chronique de stade 3 ou plus. Au-dessus de 90 : DFG normal ou augmenté (stade 1 si marqueurs d'atteinte rénale).

## Pièges d'unités

**⚠ PIÈGE Même examen, deux unités**
La même glycémie s'écrit 3,90–5,50 mmol/L ou 0,70–1,00 g/L ; la créatinine (homme) 60–115 µmol/L ou 7–13 mg/L. Lire l'unité avant de comparer un résultat à une norme.

**⚠ PIÈGE Fraction ou pourcentage**
Hématocrite 0,42 = 42 % ; HbA1c < 0,06 = < 6 %. Même valeur, deux écritures (× 100).

**⚠ PIÈGE TP, INR, TCA : trois écritures**
TP en %, INR sans unité, TCA en **rapport** malade/témoin. Ne pas comparer un TP à une cible d'INR.

**✓ EXEMPLE Deux calculs**
TCA : 45 s ÷ 30 s = 1,50 (au-dessus de 1,20).
Clairance : 1,50 mL/s × 60 = 90 mL/min.
*Valeurs d'exercice (TCA), pas des résultats de patient.e.*

## Repères infirmiers

**NOTE CLINIQUE Kaliémie élevée et hémolyse**
**Signaler d'abord** une kaliémie élevée, selon le protocole du service. Une hémolyse du prélèvement peut donner une fausse hyperkaliémie : un contrôle au laboratoire, sans garrot, peut être demandé. Il ne retarde pas le signalement.

**NOTE CLINIQUE INR sous AVK**
La cible est fixée par le prescripteur selon l'indication : 2 à 3 le plus souvent, 3 à 4,5 pour certaines valves mécaniques. Au-dessus de la cible : risque de saignement (surdosage possible), à signaler selon le protocole.

*Sources : Conseil scientifique des concours de l'internat en pharmacie, « Valeurs biologiques usuelles », V8 (19.11.2009), diffusé par le CNG ; VIDAL Recos « AVK (traitement par) » (21.10.2025) ; VIDAL, estimation du DFG (2022) ; La Revue du Praticien (stades de MRC, 2022 ; hyperkaliémie, 2026).*